Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 34ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810520

Processo nº 0019259-70.2025.8.17.2001

AUTOR(A): ERNANI JOSE COELHO LEITAO

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA C/C COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA ANTECIPADA** ajuizada por **ERNANI JOSÉ COÊLHO LEITÃO**, através de advogado constituído (ID 192749635), em face da **BRADESCO SAÚDE S/A**, todos devidamente qualificados.

À saída, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e pela prioridade na tramitação processual, com fundamento no art. 71, *caput*, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idosos), por constar com 81 (oitenta e um) anos de idade (ID 196777476).

Narrou a inicial que o autor é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial da ré há vários anos – BRADESCO SAÚDE TOP, identificação de 838264200019002 e 838264200019010, juntando carteira do plano no ID 196777468), adimplente com as mensalidades, atualmente no valor de R$ 3.067,69, conforme comprovantes de pagamentos dos últimos meses (IDs 196777469 e 196777470).

Declarou que, em virtude de suas patologias – "*portador de cardiopatia isquêmica com passado de CRVM e implante de prótese aórtica há 30 anos, evoluindo com função ventricular esquerda com fração de ejeção reduzida (32%), além de Mal de Parkinson e Qdo Demencial avançado. Internado em 10/01/25 com Covid positivo, complicado com infecção respiratória, evoluiu com queda do estado geral e rebaixamento do nível de consciência sendo realizado gastrotomia para alimentação e medicação. Atualmente com dependência*

total de cuidados de enfermagem, necessitando ainda de suporte fisioterápico e nutricional (dieta enteral)" – foi solicitado a continuidade do tratamento em *home care*, conforme laudo médico de ID 196777472, pedido reiterado no laudo médico de ID 196777473.

No laudo de ID 196777473, a médica Paula Elizabeth Ferraz p. Moura Maniçoba, CRM 23832 – PE, prescreveu a solicitação nos seguintes termos: "*necessitando de suporte domiciliar com cama hospitalar, colchão pneumático, dieta enteral, técnico de enfermagem para treinamento e suporte do paciente e familiares; possui indicação de protetores cutâneos para prevenção de lesões por pressão, além de fisioterapia motora diária e fonoterapia diária, com suporte mensal de médico, enfermeira e nutrição, para adequação progressiva do cuidado*".

Contudo, a parte autora asseverou que o pedido está em análise por cerca de mais de 30 (trinta) dias. Afirmou que foi informado pelo Hospital Santa Joana, nosocômio no qual o autor está internado, que os procedimentos não foram integralmente autorizados pela ré, e que esta, em contato telefônico, informou que, após análise da junta médica, os procedimentos só foram parcialmente autorizados.

Pontuou a inicial que os procedimentos são caros, e que a família do autor condições financeiras de dar o suporte requerido e necessário ao demandante. Assim, foi proposta a presente demanda, com pedido de antecipação de tutela para compelir a ré a, imediatamente, autorizar "*os procedimentos conforme requerido pelos médicos do autor*".

No mérito, além da confirmação da tutela antecipada, pediu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como nas custas e nos honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Ao final, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo existente, e a não designação da audiência de conciliação, bem como atribuiu à causa o valor de R$ 20.000,00.

Decisão inicial (ID 196853496) determinou que a parte autora emendasse à inicial para: **(1) retificar o valor da causa**, apresentando, orçamento por estimativa do fornecimento do serviço de *home care*, nos termos pretendidos e em consonância com o laudo médico (ID 196777473), somando ao valor do dano moral perseguido, sob pena de indeferimento da inicial; e **(2)** comprovar condição econômica condizente com a gratuidade judiciária requerida.

O autor ofertou emenda à inicial (ID197739864). Retificou o valor da causa para R$ 57.308,26, correspondente ao dano moral pretendido (R$ 20.000,00), somado ao valor estimado do serviço *home care* (R$ 37.308,26), conforme orçamento (não acostado aos autos). Ademais, juntou documentos comprobatórios de sua condição financeira (IDs 197741133 a 197741140).

Decisão interlocutória de ID 198232929: (i) recebeu a emenda à inicial, acolhendo a retificação do valor da causa para a quantia de R$ 57.308,26; (ii) deferiu o benefício da gratuidade judiciária ao autor; (iii) concedeu a tutela provisória de urgência para determinar

que a ré forneça o serviço de internação domiciliar, conforme laudo do médico assistente, incluindo: *Cama hospitalar; Colchão pneumático; Dieta enteral; Técnico de enfermagem para treinamento e suporte do paciente e familiares; Protetores cutâneos para prevenção de lesões por pressão; Fisioterapia motora diária; Fonoterapia diária; Suporte mensal de médico, enfermeira e nutrição;* (iv) ordenou a citação da ré para ofertar contestação.

A ré informa que procedeu com o cumprimento da liminar, no entanto, conforme declaração do prestador do serviço (ID 199799402) a família recusou o programa de atendimento domiciliar, em razão de pleitear enfermagem 24 horas por tempo indeterminado, fornecimento de medicamentos e fraldas, não havendo, todavia, como requere além do que está previsto na decisão judicial.

Requer, assim o reconhecimento do cumprimento (ID 199799404)

Bradesco Saúde ofertou **contestação** (ID 200449759) sustentando, preliminarmente: **ausência de negativa e de pretensão resistida**, alegando carência de ação com base na decisão do STF no RE 631240, argumentando que não há documentos suficientes nos autos que comprovem negativa de cobertura, informando que em diversas datas (05/08/2024, 20/01/2025 e 28/01/2025) foram recepcionados relatórios médicos solicitando atendimento domiciliar e que houve autorização do PAD (Programa de Atenção Domiciliar) tecnicamente indicado pela prestadora, sendo que as tratativas foram finalizadas por motivos diversos (alta hospitalar, confecção de gastrostomia, não aceite da família).

No mérito, defendeu: (2) **inexistência de previsão legal para tratamento de Home Care**, sustentando observância à Resolução Normativa 465 da ANS e ao Parecer Técnico nº 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, argumentando que a assistência domiciliar é de cobertura não obrigatória pela Lei 9.656/98, ressalvando seu caráter opcional conforme art. 10 da referida lei; (3) **distinção entre Home Care e atendimento domiciliar**, esclarecendo que a primeira é internação domiciliar caracterizada pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo, enquanto a segunda são atividades de caráter ambulatorial; (4) **ausência de cobertura contratual**, demonstrando que o contrato possui exclusão expressa na cláusula 5.1, alínea "b", que exclui "consultas, assistência e internação domiciliar ou qualquer outra assistência realizada por profissional de saúde em ambiente domiciliar (home care)"; (5) **não obrigatoriedade de fornecimento de itens de higiene pessoal e medicamentos de uso domiciliar**, citando jurisprudência do STJ (REsp 1.692.938/SP) que considera lícita a exclusão desses itens; (6) **distinção entre serviço de Home Care e cuidador**, explicando que cuidador é pessoa capacitada para auxiliar o paciente em necessidades básicas, diferente do enfermeiro que possui formação técnica; (7) **necessidade de realização de perícia judicial** para verificar a divergência entre a avaliação técnica do PAD e o pleito autoral; (8) **reembolso apenas nos limites contratuais** caso seja utilizada rede particular não referenciada; (9) **necessidade de desembolso efetivo** como pressuposto para reembolso, citando decisão do STJ no REsp 1.959.929/SP; (10) **preservação do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro**, argumentando que a extensão indiscriminada de coberturas prejudica a massa de segurados; (11) **inexistência**

de danos morais, sustentando que eventual descumprimento contratual não gera dano moral; (12) **não cabimento da inversão do ônus da prova**, alegando ausência dos pressupostos legais.

A ré juntou extensa documentação incluindo histórico de atendimentos, pareceres técnicos da ANS, jurisprudência, laudos médicos das prestadoras e comprovantes de tentativas de autorização do tratamento domiciliar, argumentando que sempre tentou viabilizar o atendimento conforme critérios técnicos, mas que houve óbices operacionais (alta hospitalar, procedimentos médicos, não aceite familiar).

A operadora de saúde informou a interposição **do Agravo de Instrumento nº 0009713-43.2025.8.17.9000**, em face da decisão concessiva da tutela e, em seguida, informou não ter mais provas a produzir (ID 203509679).

A parte autora, por seu turno, atravessou petição informando que não foi fornecido ao paciente e familiares o técnico de enfermagem para o treinamento e suporte, de modo que arcaram com pagamento do serviço, ao longo do período de 08/04/2025 até 02/05/2025, no total de 25 diárias, pagando a quantia de R$ 5.000,00, tendo sido ajuizada nova demanda, desta feita sob nº **0029469-83.2025.8.17.2001**, para que fosse fornecido o técnico de enfermagem a partir do dia 14/05/2025 (ID 204833499).

Em sucessivo, a parte autora ofertou réplica no ID 204833502, pugnado pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, por não haver necessidade de produção de prova.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa relatar. Decido.

Verifico que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC/2015.

Convém ressaltar que o CPC/2015 adota o sistema do convencimento motivado (ou persuasão racional), segundo o qual cabe ao julgador decidir pela necessidade ou não de se realizar determinada prova para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, pode o juízo indeferir as diligências que entender inúteis, se considerar que os elementos constantes nos autos já são suficientes para embasar a sua persuasão. Neste sentido, seguem julgados das turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

> *AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. J**ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ**. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE*

SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. ***A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, os quais preceituam que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias.*** *4. (...)8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,* ***Terceira Turma****, julgado em 28/11/2022, DJe de* ***9/12/2022****.)*

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, V, DO NCPC. INEXISTÊNCIA. ***PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.*** *NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 489, § 1º, V, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2.* ***Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.*** *3.(...) (AgInt no AREsp n. 1.567.720/SP, relator Ministro Raul Araújo,* ***Quarta Turma****, julgado em 26/10/2020, DJe de* ***24/11/2020****.)*

Quanto à alegada **ausência de negativa e pretensão resistida,** verifico que tal argumento não merece prosperar. A documentação juntada aos autos demonstra que houve sim resistência por parte da operadora, que após análise técnica autorizou apenas parcialmente os procedimentos solicitados pelo médico assistente. O próprio fato de o autor ter necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para obtenção da tutela de seu direito já evidencia a existência de pretensão resistida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

No mérito, a questão controvertida gira em torno da obrigatoriedade de cobertura do tratamento home care solicitado pelo médico assistente e da configuração de danos morais.

Por oportuno, cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual, ressaltando-se que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde da contratante.

Da análise dos autos, verifico que o autor é beneficiário do plano de saúde da ré há vários anos, na modalidade BRADESCO SAÚDE TOP, conforme documentação juntada, e que sempre adimpliu com suas obrigações contratuais.

Segundo relatado, o autor, idoso de 81 anos, encontra-se em estado de saúde grave, com quadro de "*cardiopatia isquêmica com passado de CRVM e implante de prótese aórtica há cerca de 30 anos, evoluindo com disfunção ventricular esquerda com fração de ejeção reduzida (32%), além de Mal de Parkinson e Quadro Demencial avançado*".

Ademais, consta dos autos que o autor foi internado em **10/01/2025** com Covid positivo, complicado com infecção respiratória, tendo evoluído com queda do estado geral e rebaixamento do nível de consciência, sendo realizada gastrostomia para alimentação e medicação, conforme laudo médico de ID 196777472.

Segundo o **laudo médico** da Dra. Paula Elizabeth Ferraz P. Moura Manicoba (CRM-PE 23823), juntado sob ID 196777473, o autor necessita de "*suporte domiciliar com cama hospitalar, colchão pneumático, dieta enteral, técnico de enfermagem para treinamento e suporte do paciente e familiares; possui indicação de protetores cutâneos para prevenção de lesões por pressão, além de fisioterapia motora diária e fonoterapia diária, com suporte mensal de médico, enfermeira e nutrição, para adequação progressiva do cuidado*".

Restou demonstrado ainda que, apesar dos pedidos médicos, a ré recusou-se a autorizar integralmente os procedimentos solicitados, <u>autorizando apenas parcialmente após análise de junta médica</u>, sem maiores explicações.

É importante ressaltar que cabe ao médico a decisão acerca do tratamento a que deverá se submeter o seu paciente, não podendo o plano negar o custeio quando prevê cobertura para a moléstia que acomete o paciente, ou, ainda, autorizar tratamento distinto do indicado pelo médico assistente, profissional que detém capacidade técnica para isso.

Registre-se que a Corte da Cidadania já consolidou entendimento no sentido de que "***é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar***" (AgInt no AREsp n.1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Outrossim, segundo o STJ, "*o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor*" (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Entendimento reiterado em julgado mais recente da Corte:

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
>
> 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
>
> 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
>
> 3. **Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).**
>
> 4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal.
>
> 5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos

morais. Precedentes.

6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021**, DJe 25/06/2021**)

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco pacificou a matéria, emitindo a **Súmula nº 07,** que assim prevê: "*É abusiva a exclusão contratual de assistência médica domiciliar (home care)*".

Por outra vertente, é de se supor que quem adere a um plano de saúde ou seguro saúde procura, na verdade, uma situação de tranquilidade financeira na ocasião da enfermidade. Almeja inteira proteção e não parcial, mesmo porque a ninguém é dado escolher as moléstias que vão lhe afligir para delas sofrer em tempo certo e determinado.

É preciso assegurar ao consumidor a efetiva proteção almejada ao ensejo da realização do contrato, de poder proteger sua vida, com os recursos que a medicina lhe oferta, na medida em que no bojo dos autos resta explicitado e incontroverso a necessidade da concessão do *home care* ao demandante.

Noutra banda, importa ser dito ainda que os **insumos essenciais para a manutenção de suas condições clínicas** figuram como desdobramento da internação domiciliar, de maneira que está inserido no serviço fornecido pela OPS. Enfim, se tratando o home care de modalidade de **internação na forma domiciliar, prestado o serviço, os insumos e medicamentos decorrentes da sua manutenção são de responsabilidade da seguradora de saúde, pois o home care é um desdobramento do serviço hospitalar**

Neste sentido, seguem recentes julgados do STJ, TJMG e do TJSP:

RECURSO ESPECIAL. **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA**. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. **O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar**. Precedentes. 4. **A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto**

tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. **Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente**, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. **PLANO DE SAÚDE. INSUMOS E MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. DESODOBRAMENTO DO HOME CARE**. COBERTURA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NAO PROVIDO. - Se tratando o home care de modalidade de **internação na forma domiciliar, prestado o serviço, os insumos e medicamentos decorrentes da sua manutenção são de responsabilidade da seguradora de saúde, pois o home care é um desdobramento do serviço hospitalar** - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000220819973002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIETA ENTERAL E FRALDAS EM HOME CARE – NEGATIVA DE CUSTEIO – **Autora idosa, de 92 anos de idade, portadora de sequelas de AVC isquêmico, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial crônica, dificuldade de deglutição – Necessidade de dieta enteral especial a ser administrada por sonda nasogástrica** conforme recomendação da nutricionista responsável por acompanhá-la, **necessitando também de insumos e materiais (equipos, sondas, frascos) que viabilizem o procedimento, além de fraldas geriátricas - Ré que já vem custeando a internação em regime de home care, com fornecimento de assistência médica, de enfermagem e equipe multidisciplinar, mas se nega a custear a dieta enteral e as fraldas descartáveis** - Alimentação enteral que deve ser custeada integralmente pela ré, pois inerente ao estado grave de saúde da autora decorrente das moléstias que a acometem - **Quadro neurológico apresentado pela autora que demanda a utilização de item mínimo e básico de higiene, como as fraldas descartáveis, em razão das sequelas de suas enfermidades e que estão inseridas dentre as formas de redução de risco de doenças e seus agravos - Dever de custeio pela ré** - Danos morais caracterizados - Situação de aflição e sofrimento da paciente em fragilizado estado de saúde – Sentença mantida em todos os seus termos - Honorários recursais indevidos – Ré

> que já foi condenada na r. sentença no limite máximo de 20% sobre o valor da condenação - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025364120188260323 SP 1002536-41.2018.8.26.0323, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 09/04/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: **09/04/2020**)

Portanto, revela-se injusta a negativa de cobertura perpetrada pelo plano de saúde, prosperando o pleito autoral no tocante à obrigação de fazer.

Quanto ao pedido de **indenização por danos morais**, este também é procedente. Conquanto o mero descumprimento contratual não gere, por via de regra, danos morais, o caso dos autos demonstra merecer tratamento diferenciado. A parte autora estava em situação de fragilidade emocional e física, posto que acometida de doença grave, necessitando do acompanhamento domiciliar.

Suportando a parte demandante não só o sofrimento físico, mas, também, a angústia de moléstia grave, cujo tratamento a ré negou-se a custear, resta claro que seu abalo psicológico não se limitou a mero aborrecimento. Insofismável, no caso sob apreço, o dano moral que sofreu o demandante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a violação a direitos da personalidade, a exemplo dos direitos à saúde e à vida, caracteriza, por si só, o dano moral, não sendo necessária sequer a ocorrência de reação psíquica da vítima, como os sentimentos de dor, vexame, sofrimento, etc[1][1].

Assim, o dano moral resta configurado, por ter a empresa demandada agido em desrespeito aos mais preciosos bens de um indivíduo, que são sua vida, saúde e dignidade. O entendimento é esposado pelo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. **PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ**. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "**é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar**" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. **Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"** (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.139.848/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de **30/3/2023.**)

Na mesma esteira, segue recente julgado do TJPE:

PROCESSUAL CIVIL. **PLANO SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO STJ. SÚMULA. 07, TJPE. DANO MORAL CONFIGURADO.** RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. §11 DO ARTIGO 85, CPC.1. Demonstrada que há cobertura do plano de saúde para a doença a que foi acometida a autora, não deve o plano de saúde opinar quanto ao tratamento recomentado pelo médico assistente - que é a quem compete dizer o tipo e o período respectivo de tratamento ao paciente. Nesse sentido, deve-se entender como médico assistente deve ser compreendido como aquele que cuida do estado clínico do paciente, que o acompanha a evolução da doença e tem convicção das necessidades diárias do enfermo, ante a clareza das necessidades próprias da doença.2. Descabida a negativa do custeio do Home Care, na forma prescrita pelos médicos assistentes, com base na falta de previsão contratual de cobertura do atendimento domiciliar, consoante os precedentes do e. STJ e deste Tribunal de Justiça. 3**. Mostra-se completamente exangue - e sem qualquer força persuasiva - o argumento de que o dano moral não ficou provado na hipótese ora submetida ao voluntário crivo da revisão. É que, em casos do tipo, a responsabilização resulta da singela circunstância de o fato contundir com direito da personalidade do lesado (damnum in re ipsa), tudo como aqui se passou**.4. O direito à reparação ou à compensação, como é de todos sabido, encontra consagração no artigo 5º incisos V e X da Constituição da República, no artigo 222 do Código Civil de 2002 e no artigo 6º inciso VI do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sem contar com as previsões contidas em legislações extravagantes.5. A respeitável sentença recorrida efetuou equilibrada análise da natureza e gravidade do ato lesivo, da intensidade da ofensa, da condição social e política do ofendido, bem assim da capacidade econômico-financeira do agente causador do dano, pelo que deve ser mantido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Apelação Cível 574587-90041805-57.2015.8.17.0001, **Rel. Frederico Ricardo de Almeida Neves,** 1ª Câmara Cível, julgado em 17/10/2022, DJe **28/11/2022**)

Suficientemente demonstrado o dano de índole moral, resta fixar o valor da indenização devida, o que faço levando em consideração a gravidade do fato em si, a extensão do dano sofrido, o tempo pelo qual o autor permaneceu em desgaste físico e emocional, nos termos do art. 944 do CC, razão por que arbitro a **indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).**

Por derradeiro, tendo em vista que o tratamento prescrito ao autor é por tempo indeterminado, reputo cabível que seja apresentado laudo médico atualizado ao plano de saúde a cada seis meses, a contar da data da intimação da presente sentença.

No mais, no que tange ao **reconhecimento ou não do descumprimento da tutela antecipada** anoto que será analisada na fase seguinte, do eventual cumprimento de sentença e cobrança da multa.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no art. 487, I, do CPC:

a) **JULGO PROCEDENTE** o pedido para condenar a parte **ré** a **fornecer** o serviço de **internação domiciliar (home care)**, conforme **laudo do médico assistente de ID 196777473**, ou seja, incluindo: Cama hospitalar; Colchão pneumático; Dieta enteral; Técnico de enfermagem para treinamento e suporte do paciente e familiares; Protetores cutâneos para prevenção de lesões por pressão; Fisioterapia motora diária; Fonoterapia diária; Suporte mensal de médico, enfermeira e nutrição, **ratificando a tutela antecipada de ID** 198232929.

Caberá a parte autora, por seu turno, apresentar laudo médico atualizado ao plano de saúde a cada seis meses, a contar da data da intimação da presente sentença.

b) JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais, arbitrada em **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a contar do presente arbitramento, e com incidência de juros de mora pela Taxa Selic, abatido o IPCA, a partir da citação, tudo até o efetivo pagamento.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e obrigação de fazer, referente ao tratamento prescrito – limitado ao período máximo de 03 (três) meses, em atendimento a Súmula 199 do TJPE), na forma do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Após o trânsito em julgado, verificada a inércia da parte interessada, arquivem-se independentemente de nova conclusão.

Oficie-se ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 0009713-43.2025.8.17.9000 dando ciência da presente sentença.

Após o trânsito em julgado, proceda a Diretoria Cível à emissão das guias de custas devidas pela parte demandada, com sua posterior intimação para recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem o pagamento:

i) expeça-se ofício à Procuradoria-Geral do Estado, exclusivamente por meio eletrônico, sat@pge.pe.gov.br (mailto:sat@pge.pe.gov.br), se o débito for igual ou superior a R$4.000,00 (quatro mil reais), caso em que o expediente também deverá ser acompanhado de cópia do título executivo judicial (sentença exequenda e, se houver, acordão), instrumentos procuratórios, atos constitutivos e outros documentos relevantes para o cumprimento de sentença, nos termos do art. 2º, VII, da Instrução Normativa nº 13, de 25 de maio de 2016, do TJPE (art. 3º, I, do Provimento 03/2022, de 10-03-2022, do Conselho da Magistratura;

(ii) expeça-se ofício ao Comitê Gestor de Arrecadação, por meio eletrônico, se o débito for inferior a R$4.000,00 (quatro mil reais) (art. 3º, II, do Provimento 03/2022- CM).

Atente a Secretaria desta Vara ao disposto no art. 3º, § 1º e art. 4º, do Provimento 03/2022 do CM .

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Recife, 27 de maio de 2025.

Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

---

[1][1] STJ, 4ª Turma, REsp 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 17/3/2015.

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
27/05/2025 10:50:58
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 205308301

25052710505851900000199967716

IMPRIMIR GERAR PDF